Obezita ako zdravotnícka „nákladová“ diagnóza: čo znamená pre prístup k GLP-1 liečbe a nepriamo aj pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 02.07.2026



Ilustračná scéna. O dostupnosti liečby nerozhoduje len účinok – a dôsledky nesie aj nefrológia.

Obezita sa v systémoch zdravotnej starostlivosti čoraz častejšie posudzuje aj z hľadiska nákladov – nielen ako klinická diagnóza, ale aj ako položka, ktorá vytvára stále ďalšie výdavky. Článok na Medscape od Amy Faith Ho (MD, MPH) rozoberá dilemu, či má systém platiť za obezitu ako za prevenciu (drahými liekmi zo skupiny GLP-1), alebo bude aj naďalej hradiť najmä jej neskoršie následky. Hoci ide o americkú zdravotnú politiku (Medicare a Medicaid), otázka má priamy dosah aj na nefrológiu.

Prečo by sa nefrológ mal zaujímať

Obezita nie je len „metabolický problém“. Je to dlhodobý spúšťač hypertenzie, diabetu 2. typu, dyslipidémie, spánkového apnoe a systémového zápalu. V nefrológii sa tieto súvislosti neskôr často prejavia rýchlejšou progresiou chronickej choroby obličiek (CKD), vyšším kardiovaskulárnym rizikom a väčším počtom pacientov na dialýze. Rozhodnutia o úhrade a dostupnosti účinnej liečby preto nie sú iba otázkou „zdravotníckej politiky“ – ovplyvňujú aj klinické výsledky.

Ťažiskom textu je plán BALANCE a následné zmeny okolo tzv. programu Medicare GLP-1 Bridge.

Prevencia verzus manažment neskorších následkov

Článok opisuje model BALANCE ako snahu presunúť logiku systému od platenia „za chorobu až následne“ k plateniu „za prevenciu“ prostredníctvom drahých liekov (GLP-1). Model bol podľa textu koncipovaný tak, aby sa terapeutický liek kombinoval so sprievodnou behaviorálnou podporou, pričom časť implementácie mala prebiehať postupne – najprv v programe Medicaid a potom v Medicare.

Pred spustením v Medicare však došlo k posunu: dočasný program Bridge sa predĺžil a trvalé riešenie zostalo

nejasné. Z praktického hľadiska to znamená, že časový horizont dostupnosti liekov je pre časť pacientov kratší a neistý.

Medicare GLP-1 Bridge: čo je podstatné pre prax (a pre pacienta)

Podľa textu môžu počas „mostíkového“ (bridge) obdobia niektorí poistenci s obezitou ako kvalifikačnou diagnózou získať vybrané lieky zo skupiny GLP-1 za zníženú mesačnú úhradu. Autorka zároveň zdôrazňuje, že ide o provizórny režim s obmedzenou dobou platnosti a že po jeho skončení sa zásadná otázka skôr odkladá, než rieši.

Pre nefrológa je z toho relevantné najmä toto:

- liečba obezity (GLP-1) môže byť pre CKD a kardiometabolické riziko nepriamo „časovo citlivá“,
- ak je dostupnosť nestabilná, zhoršuje sa adherencia aj dlhodobý prínos,
- v praxi potom často narážame na to, že pacient liečbu začne, no v pokračovaní mu niečo zabráni.

Pri rozhodovaní o konkrétnom pacientovi sa preto oplatí mať pripravený plán: zdokumentovať indikáciu a očakávaný prínos pre kardiometabolický profil aj renálne riziko a včas riešiť administratívne i logistické prekážky.

„Zaplatiť teraz, alebo zaplatiť neskôr“: viac než slogan

Autorka stavia argumentáciu na jednoduchej voľbe: buď systém investuje do liečby obezity teraz, alebo zaplatí neskôr – za infarkt, zlyhanie srdca, dialýzu, endoprotézy a ďalšie nákladné následky.

V texte sú uvedené aj odhady úspor a dodatočných nákladov v horizonte niekoľkých rokov (z rôznych inštitúcií). Berme ich ako orientačné čísla, pretože skutočné výsledky závisia od:

- reálnej miery adherencie,
- podielu pacientov, ktorí liek dostanú a udržia dlhodobo,
- štruktúry populácie (komorbidity, štádiá CKD, diabetes),
- a od toho, ako presne sa v modeloch definujú „kompenzácie“ (offsety) nákladov.

Čo by mali odborníci komunikovať pacientom aj systému

Z článku podľa mňa vyplývajú tri body:

1. **Obezita je chronické ochorenie s merateľným rizikom pre obličky.** Pacientovi to zrozumiteľne vysvetlime ako „investíciu do budúcnosti obličiek“, nie iba do hmotnosti.
2. **Neistota úhrady je klinický problém, nie administratívna drobnosť.** Pri pacientoch s CKD, diabetom a vysokým kardiovaskulárnym rizikom môže nestabilný prístup zhoršiť dlhodobé výsledky.
3. **Ak má pacient prístup k liečbe, kľúčové je myslieť na kontinuitu.** Aj keď článok rieši zdravotnú politiku, prakticky to znamená včas plánovať pokračovanie liečby, sledovať toleranciu a metabolické parametre a dokumentovať odpoveď.

Poznámka na záver

Ide o politicko-zdravotnícky materiál, ktorý sa môže meniť. Pri riešení konkrétnej dostupnosti pre pacienta v danom období odporúčam overiť aktuálne podmienky v primárnych zdrojoch (CMS a príslušné dokumenty k úhrade).

Zdroj: *Amy Faith Ho, Obesity Dilemma: Pay Now or Pay for What It Becomes Later , Medscape (2026).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=obezita-nakladova-diagnoza-glp1-pristup-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.